

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EI-PLUTCHIK · ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE PLUTCHIK

Plutchik's Impulsivity Scale — Autoinforme dimensional de reactividad impulsiva y descontrol conductual

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Escala de Impulsividad de Plutchik (EI-Plutchik)
Autores Originales	Robert Plutchik y Herman M. van Praag (1989)
Adaptación Española	Gabriel Rubio, M. A. Jiménez-Arriero, F. J. Ponce, J. Santo Domingo et al. (1998)
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico unidimensional breve
Población Diana	Adolescentes y adultos (>= 15 años) en población general, psiquiátrica y penitenciaria
Tiempo de Aplicación	3 a 5 minutos (15 ítems autoadministrados)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 4 opciones: Nunca (0), A veces (1), A menudo (2), Casi siempre (3)
Finalidad Clínica	Detección de rasgo impulsivo desadaptativo, predicción de conductas hetero y autoagresivas, adicciones y triaje de riesgo en urgencias

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Robert Plutchik y Herman M. van Praag formularon su modelo neurobiológico integrado a finales de la década de 1980, proponiendo que la impulsividad, la agresión hacia terceros y la conducta suicida comparten un sustrato fisiopatológico común caracterizado por la hipofunción del sistema serotoninérgico central (5-HT). Dentro de este paradigma, la impulsividad se conceptualiza como un fallo estructural del control inhibitorio que predispone al individuo a reaccionar de forma inmediata ante estímulos internos o externos sin evaluar los riesgos ni demorar la respuesta.

La Escala de Impulsividad fue construida para correlacionar con las escalas hermanas de Riesgo de Suicidio (RS) y Riesgo de Violencia (RV) de Plutchik. Evalúa una amplia gama de manifestaciones impulsivas cotidianas: compras innecesarias, dificultad para planear el futuro, pérdida de paciencia en colas o tráfico, tendencia a interrumpir a los demás, promiscuidad o sexo no planificado, y propensión a actuar por arrebatos emocionales.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Facetas Conductuales	Nº Ítems	Manifestaciones Sintomáticas Evaluadas
Impaciencia e Inquietud	4 ítems	Dificultad para esperar turnos, impaciencia al conducir y necesidad de comer rápido.
Falta de Premeditación	4 ítems	Compras compulsivas de objetos superfluos, no planear vacaciones y gastar sin control.
Descontrol Emocional	4 ítems	Decir lo primero que viene a la cabeza, interrumpir conversaciones y arranques de ira.
Conductas de Riesgo	3 ítems	Apetencia por sensaciones de peligro físico y relaciones sexuales imprevistas.

Estructura psicométrica: Aunque agrupa facetas conductuales, la escala se interpreta de forma unidimensional para proporcionar un índice global de impulsividad de 0 a 45 puntos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EI-PLUTCHIK

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.72 a 0.77 en la validación española de Rubio et al. (1998) en pacientes ambulatorios y controles sanos.
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación intraclase $r = 0.84$ a los 15 días en sujetos no sometidos a intervención farmacológica.
Validez Discriminante	Distingue con gran significación estadística ($p < 0.001$) entre pacientes con trastornos de la personalidad del grupo B, trastorno por dependencia del alcohol y controles normales.
Validez Concurrente	Correlación elevada con la escala BIS-11 de Barratt ($r = 0.68$) y con la escala de Riesgo de Suicidio de Plutchik ($r = 0.59$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Asignación Directa de Puntos:** Cada ítem se valora de 0 a 3 según la frecuencia: Nunca = 0 puntos; A veces = 1 punto; A menudo = 2 puntos; Casi siempre = 3 puntos.
- Sin Ítems Invertidos:** Todos los 15 reactivos se suman en sentido directo.
- Puntuación Total:** Suma algebraica simple de los 15 ítems.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 45 puntos.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Estratificación	Percentil Aprox.	Interpretación Psicopatológica y Funcional
0 a 14 puntos	Baja Impulsividad	< P50	Adecuada capacidad reflexiva y control de los impulsos motor y afectivo.
15 a 19 puntos	Impulsividad Media	P50 a P75	Nivel adaptativo promedio en población general; sin disfunción clínica.
20 a 29 puntos	Impulsividad Alta	P76 a P90	Punto de corte clínico. Mayor riesgo de conductas lesivas y adicciones.
30 a 45 puntos	Impulsividad Extrema	> P90	Grave labilidad inhibitoria; alto riesgo de agresión y tentativa autolítica.

PUNTO DE CORTE OFICIAL EN ESPAÑA (EI-PLUTCHIK ≥ 20): El estudio de validación española de Rubio et al. (1998) determinó que una puntuación de 20 o superior discrimina con máxima sensibilidad y especificidad a los sujetos con rasgos impulsivos patológicos, asociándose a un incremento significativo en el riesgo de tentativa de suicidio y violencia reactiva.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EI-PLUTCHIK

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación Rápida: Administrar en consultas de salud mental ambulatoria o urgencias ante sospecha de patología de descontrol de impulsos.

Paso 2: Triage Clínico:

- **Si EI-Plutchik < 20:** Rasgo impulsivo normativo. No requiere intervención farmacológica ni psicoterapéutica focalizada en la inhibición.
- **Si EI-Plutchik >= 20:**
 1. Aplicar de inmediato la Escala de Riesgo Suicida (RS-Plutchik) y explorar acceso a medios letales.
 2. Evaluar consumo concomitante de alcohol o psicoestimulantes que desinhiban la corteza prefrontal.
 3. Indicar psicoterapia cognitivo-conductual (entrenamiento en parada de pensamiento, habilidades STOP de DBT) y valorar estabilizadores del ánimo o anticonvulsivantes (topiramato, lamotrigina, litio).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 27 años, con antecedentes de consumo esporádico de cocaína y múltiples sanciones de tráfico por exceso de velocidad, derivado a salud mental tras un altercado violento en la vía pública.

Evaluación Psicométrica Inicial: EI-Plutchik = 31 / 45 puntos (Impulsividad Extrema, > P90).

- Admite comprar compulsivamente artículos que no necesita (ítem 3 = Casi siempre).
- Refiere incapacidad de guardar fila sin enfurecerse (ítem 2 = Casi siempre) y decir cosas hirientes de las que se arrepiente al instante (ítem 6 = A menudo).
- Reconoce mantener relaciones íntimas con desconocidos sin protección de forma impulsiva (ítem 14 = Casi siempre).

Intervención y Manejo: El perfil confirmó un rasgo de impulsividad desadaptativo severo sin componente afectivo bipolar primario. Se inició entrenamiento psicoterapéutico grupal en control de la ira y habilidades de solución de problemas, asociado a dosis bajas de aripiprazol (5 mg/día) para modular la reactividad dopaminérgica. En el seguimiento a los 6 meses, la puntuación en la EI-Plutchik descendió a 18 puntos, sin nuevos incidentes de agresividad ni sanciones de tráfico.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Puntuaciones >= 20 en presencia de síntomas depresivos multiplican por 4 el riesgo de suicidio consumado mediante actos no planificados.
- La desinhibición paradójica por benzodiacepinas puede disparar las puntuaciones en pacientes con alta impulsividad previa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **TDAH del Adulto:** Impulsividad ligada a déficit ejecutivo persistente desde la infancia sin agresividad premeditada.
- **Trastorno Límite de la Personalidad:** Impulsividad guiada por hipersensibilidad al rechazo afectivo y disforia intolerable.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Plutchik, R., & van Praag, H. M. (1989). The measurement of suicidality, aggressivity and impulsivity. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 13(Suppl), S23–S34.
- Rubio, G., Jiménez-Arriero, M. A., Ponce, G., Fontenla, F. J., & Santo Domingo, J. (1998). Validación de la escala de impulsividad de Plutchik en población española. *Archivos de Neurobiología*, 61(2), 123–132.
- Plutchik, R., van Praag, H. M., & Conte, H. R. (1989). Correlates of suicide and violence risk: III. A two-stage screening approach. *Psychiatry Research*, 28(2), 215–225.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.